23. PRAKTISCHE HINWEISE VOR DER BEHANDLUNG DER LEBER

DAUER : 06:13 LEHRBLATT

KURSZUSAMMENFASSUNG

In dieser Sitzung lernen die Praktizierenden, die Leber unter Berücksichtigung ihrer Integration in den gesamten Körper und ihrer Beziehungen zum Herzen und den umgebenden Strukturen zu erforschen. Die Konzepte der embryonalen Motilität stehen im Mittelpunkt der Praxis, wobei die Technik mit einem neutralen Kontakt beginnt und sich zu einem tieferen Ansatz entwickelt, wodurch die primäre Respiration und das Entstehen eines therapeutischen Prozesses gefördert werden. Die Teilnehmer werden darin angeleitet, wie wichtig es ist, in Verbindung mit den embryonalen Fulkren, insbesondere der Mittellinie und dem Herzen, zu arbeiten, um die vaskulären und neurologischen Systeme zu dynamisieren und dadurch die Wirksamkeit ihrer Behandlung zu verbessern.

PRAXIS VOR DER LEBERBEHANDLUNG

In dieser Sitzung werden wir die **Leber** in Bezug auf ihre **globale Umgebung** untersuchen. Es ist unerlässlich, keinen zu **selektiven** oder **lokalen** Ansatz zu wählen.

Die Leber spielt eine zentrale Rolle bei der Organisation der hinteren Höhle der **Omenta**, der Etablierung des **Magens**, der Achse der **Milz** und des **großen Omentums**. Wir werden die Leber behandeln, dabei aber ihre Beziehung zum **Herzen** und zur hinteren Höhle der Omenta berücksichtigen, unter Verwendung eines angepassten Handgriffs.

Ziel ist es, der Leber ihre **Motilität** zurückzugeben, denn diese Motilität schafft ihre Funktion. Wir beginnen mit einem **neutralen** und oberflächlichen Kontakt, der allmählich tiefer wird, sobald sich die **primäre Respiration** manifestiert. Die Begegnung dieser beiden Neutralen ist es, die den **therapeutischen Prozess** hervorbringt.

Die Leber ist entscheidend für die Organisation des Embryos, insbesondere in der **transversalen** Achse und der Etablierung der **gastro-duodeno-pankreatiko-linealen** Achse, wodurch die gesamte Bewegung gesteuert wird. Diese Kippbewegung, die wir zuvor mit dem **venösen** und **arteriellen** Netzwerk besprochen haben, ist eine wesentliche Entwicklungsmotilität für das Wachstum. Die Leber bewegt sich in sich selbst, nicht durch Rotation, sondern durch **Verschiebung**, was ihr eine Entwicklungskraft verleiht.

Diese Motilität embryonalen Ursprungs ist fundamental. Wenn wir unsere Hände auflegen, müssen wir uns in einem **Fulcrum** positionieren, wo sich das gesamte System entwickeln kann. Beschränken wir uns auf einen lokalen Ansatz, verlieren wir das ursprüngliche Fulcrum aus den Augen.

Je näher wir dem embryonalen Fulcrum kommen, desto mehr Zugang erhalten wir zu dieser Kraft, und desto mehr Informationen kann uns der Körper liefern, da er sie kennt. Eine hohe Frequenz fördert die **regenerative Kraft**. Betrachten Sie das Wort "Fulcrum" als eine **Funktion** und nicht nur als einen einfachen Stützpunkt.

Die **Mittellinie** zum Beispiel ist ein Fulcrum für die Gesamtheit. Wir haben den Bereich des Herzens als embryonales Fulcrum identifiziert, das nicht auf einen einfachen Punkt reduziert werden kann.

Die Arbeit an der Motilität, die mit der Entwicklung des **Gehirns** verbunden ist, kann als Werkzeug dienen. Erinnern wir uns an die Krümmungen, dieses "Tai Chi" des Gehirns:

- **Expansion**
- **Kephalische Flexion**
- **Zervikale Flexion**
- **Pontine Flexion**
- **Telencephalisation**

Die Phase der Telencephalisation ist entscheidend, da sie die Aufrichtung und die Etablierung der **anterioren weißen Linie** induziert. Dies beinhaltet die Bildung des **Sterns**.

Wir können nur an der Motilität arbeiten oder **spezifische Punkte** verwenden wie:

- Die Spitze des **Monotocorte**
- Das **Supraocciput**
- Die Basis des **Occiputs**
- Das **Präsphenoid**

Diese Punkte stehen in Beziehung zu diesen Entwicklungen. Zum Beispiel ist die Spitze des Monotocorte ein wichtiger Referenzpunkt in der **submesenzephalen Flexion**.

Ich kann so den **Punkt der Stille** im sich entwickelnden System suchen, abhängig von den Auflagepunkten, auf denen ich mich positioniere. Einige Phasen werden gleichzeitig ablaufen, was die **Synchronizität** der Entwicklung illustriert.

Bezüglich der Gehirnentwicklung befindet sich ein wichtiges Überbleibsel im Bereich des **mesenterialen Systems**. Die **Dottersackachse** oder **mesenteriale Achse** ist entscheidend, um ein sich entwickelndes Gehirn zu revitalisieren.

Vaskulär ist es wichtig zu beachten, dass das Gehirn für seine Funktion und Bildung vollständig vom Herzen abhängt. Das Herz informiert das Gehirn kontinuierlich, und eine **Pulsation** ist in letzterem vorhanden.

Behalten Sie das Bild des **Septum transversum** im Auge, das sich mit der Etablierung der Leber einrollt, integriert mit der **Dotterblase**. Die Etablierung der **Amnionhöhle** ist das Ergebnis unserer vorherigen Arbeit.

Es gibt eine entwicklungsbedingte Motilitätsbewegung, die von der Leber erzeugt wird und das gesamte **hepato-gastro-duodeno-pankreatiko-lineale** System organisiert. Wir beobachten die Kippbewegung des Herzens auf seiner linken Achse, eine umgekehrte Bewegung auf globaler hepatischer Ebene und eine Gegenrotation auf der Verdauungsebene.

Wir werden zuerst an diesem großen **subdiaphragmatischen** Organisationszentrum arbeiten, indem wir die hintere Höhle der Omenta etablieren. Danach werden wir die Beziehung zwischen Leber und Herz untersuchen, die unsere beiden Arbeitspunkte sein werden.

Wir haben den **Herzeindruck**, den **Lungeneindruck** und den enormen **Leberabdruck**. Wir werden eine Arbeit an der Leber in Bezug auf die Etablierung des Herzens und des Darms durchführen, unter Anwendung eines **biodynamischen** Ansatzes.

Das bedeutet, dass wir unsere Hände auflegen und die Bewegung geschehen lassen. Wir können eine Bewegung haben, die sucht, oder eine Bewegung, die ihre Originalität ausdrückt. Wir werden diesen Punkt geben, damit sich das System reorganisieren kann.

Die Leber ist eine **Spezialisierung**, die als **fraktale Expansion** des Darms betrachtet werden kann. Sie besteht aus einer Ansammlung von **Gallengängen** mit zwei Arten von Informationen:

- Eine **vaskuläre** Information, die der **portalvenösen** Leber entspricht.
- Ein ganz rotes Gesicht kann auf ein Leberproblem **mesodermalen** Typs hinweisen.
- Ein ganz gelbes Gesicht kann auf ein Leberproblem **endodermalen** Typs hindeuten.

Diese beiden Ansätze ermöglichen es, das System komplementär zu erfassen.